AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

PSIQUIATRÍA GENERAL

Salud Mental

20 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Trastornos del Ánimo & Urgencias Suicidas

★★★ 17.1. Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES GES 3
★★☆ 17.2. Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES GES 4
★☆☆ 17.3. Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización 5
★★★ 17.4. Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal GES 6
★★★ 17.5. Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo GES 7

02 Trastornos de Ansiedad, TOC & Trauma

★★★ 17.6. Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS 8
★★☆ 17.7. Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social 9
★★☆ 17.8. Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS 10
★★☆ 17.9. Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo 11

03 Trastornos Psicóticos & Urgencias Psiquiátricas

★★★ 17.10. Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES GES 12
★★★ 17.11. Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma GES 13
★★★ 17.12. Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve GES 14
★☆☆ 17.13. Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo 15
★☆☆ 17.14. Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada 16
★☆☆ 17.19. Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense 17

04 Adicciones, Personalidad & Salud Mental Infanto-Juvenil

★★☆ 17.15. Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke GES 18
★★☆ 17.16. Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas) GES 20
★☆☆ 17.17. Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C 21
★★★ 17.18. Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria 22
★☆☆ 17.20. Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad 23

Números que tienes que saber 24
Fármacos de primera línea 26
GES de la especialidad 26
Plan de repaso de 7 días 28
Índice por prioridad ★ 29

BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS

17.1 Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

★★★ PRIORIDAD ALTA
25 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.007 Primer episodio depresivo — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Trastorno depresivo (recurrente) · Trastornos del ánimo en niños · Depresión

LO QUE TE PREGUNTAN

- El diagnóstico de Trastorno Depresivo Mayor exige al menos 5 de 9 criterios DSM-5 por **≥ 2 semanas** consecutivas, con presencia obligatoria de ánimo deprimido o anhedonia.
- En Chile, el TDM en mayores de **15 años** está cubierto por GES N° 21: la confirmación diagnóstica e inicio terapéutico deben realizarse dentro de **24 horas** desde la sospecha.
- Los ISRS (Sertralina **50-100 mg**/día o Escitalopram **10-20 mg**/día) son la primera línea farmacológica de elección en atención primaria.
- **Latencia de acción**: los antidepresivos requieren entre 2 y **4 semanas** para alcanzar su efecto terapéutico; jamás suspender precozmente por aparente ineficacia en la primera semana.
- **Regla de oro de mantenimiento**: tras lograr la remisión clínica completa, el fármaco se debe mantener a la misma dosis durante **6 a 12 meses** para evitar recaídas.

ALGORITMO · DEPRESIÓN MAYOR: DE LA SOSPECHA AL MANTENIMIENTO



TABLA 17.1 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DSM-5 Y CLASIFICACIÓN POR SUBTIPOS CLÍNICOS DE DEPRESIÓN

SUBTIPO CLÍNICO	CARACTERÍSTICAS CARDINALES	BIOMARCADORES / CLÍNICA CLAVE	FÁRMACO PREFERENCIAL
Depresión Típica / Mayor	≥ 5 de 9 criterios por ≥ 2 semanas con ánimo bajo o anhedonia	Insomnio de conciliación/intermedio, anorexia, astenia, culpa	ISRS (Sertralina 50-100 mg, Escitalopram 10-20 mg)
Depresión Melancólica	Anhedonia completa, falta de reactividad afectiva, culpa patológica	Despertar precoz (> 2 h antes), peor en la mañana, baja de peso rápida	Duales (Venlafaxina), Tricíclicos (Amitriptilina) o TEC si severa
Depresión Atípica	Reactividad del ánimo positiva transitoria, sensibilidad al rechazo	Hipersomnia diurna, hiperfagia ("carbo craving"), parálisis de plomo	ISRS, Bupropión o IMAO en casos resistentes
Depresión Psicótica	Delirios de culpa, ruina, hipocondría extrema (Cotard) o alucinaciones	Emergencia psiquiátrica · Riesgo suicida extremo · Catatonía	ISRS/IRSN + Antipsicótico atípico (Olanzapina/Quetiapina) o TEC
Depresión Estacional (SAD)	Episodios recurrentes en otoño/invierno con remisión en primavera	Hipersomnia, aumento de peso, relación con privación de luz solar	Fototerapia matinal (10.000 lux) + ISRS (Fluoxetina/Bupropión)

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Depresión sin psicosis ni riesgo	ISRS y psicoterapia	Benzodiacepina sola
Mejoría parcial, buena tolerancia	Subir la dosis	Cambiar de familia de entrada
ISRS a dosis máxima sin respuesta	Cambiar a dual	Seguir igual más tiempo

REGLA DE ORO **5 de 9 por 2 semanas** — Ánimo bajo o anhedonia obligatorio

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **3–17** (págs. 8–10) · solucionario págs. 22–24.

Clase 17.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS

17.2 Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
12 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.009 Trastorno bipolar — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Niveles plasmáticos de estabilizadores del ánimo

LO QUE TE PREGUNTAN

- Un solo episodio maníaco a lo largo de la vida es suficiente para diagnosticar Trastorno Bipolar Tipo I de forma definitiva.
- La hipomanía dura al menos **4 días**, no genera disfunción social/laboral grave y NUNCA cursa con síntomas psicóticos ni requiere hospitalización.
- Cualquier episodio expansivo que presente delirios o alucinaciones, o que requiera hospitalización, se clasifica automáticamente como MANÍA.
- El tratamiento de elección en manía aguda grave es la combinación de un antipsicótico atípico (Olanzapina, Risperidona, Quetiapina) con un estabilizador (Litio o Valproato).
- El Carbonato de Litio es el estándar de oro en prevención de recaídas y el único estabilizador con reducción demostrada del riesgo suicida.
- **Rango terapéutico de la litemia**: **0.6 a 1.0 mEq/L** en mantenimiento; se mide en sangre exactamente a las **12 horas** post-dosis.

ALGORITMO · TRASTORNO BIPOLAR: DE LA ELEVACIÓN DEL ÁNIMO AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

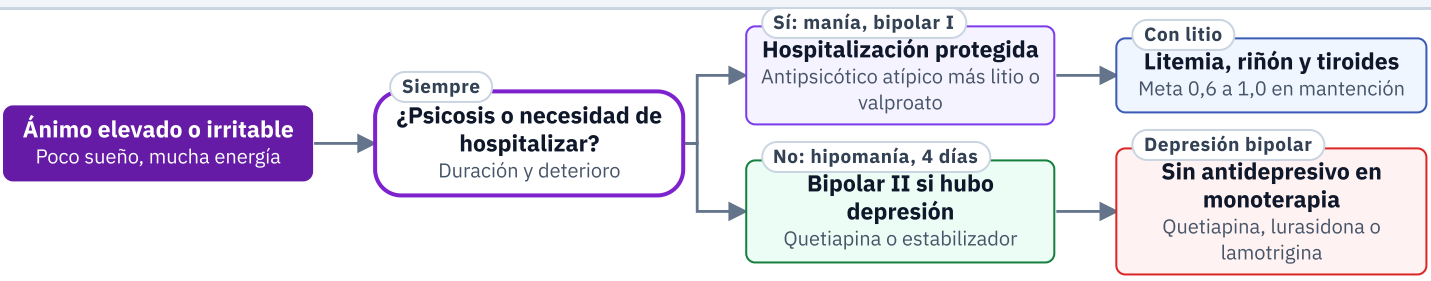


TABLA 17.2 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO: MANÍA VS HIPOMANÍA VS EPISODIO MIXTO

PARÁMETRO	EPISODIO MANÍACO (BIPOLAR I)	EPISODIO HIPOMANÍACO (BIPOLAR II)	EPISODIO MIXTO
Duración mínima	≥ 7 días consecutivos (o cualquier duración si se hospitaliza)	≥ 4 días consecutivos	Cumple criterios de manía/hipomanía + síntomas depresivos simultáneos
Disfunción funcional	Severa: incapacidad laboral, quiebra económica, problemas legales	Ausente o leve: funcionalidad social y laboral conservada	Severa con gran disforia, angustia e impulsividad
Síntomas psicóticos	Frecuentes (delirios megalomaníacos, místicos o auditivos)	ESTRICTAMENTE AUSENTES (su presencia = manía)	Pueden estar presentes (congruentes o incongruentes)
Criterio de hospitalización	Frecuentemente necesaria por riesgo físico o social	NUNCA requiere hospitalización (si requiere = manía)	Alta necesidad por riesgo suicida extremo
Diagnóstico resultante	Trastorno Bipolar Tipo I (un solo episodio lo define)	Trastorno Bipolar Tipo II (exige además depresión previa)	Especificador de Bipolar I o II según gravedad

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Psicosis o hospitalización	Manía, no hipomanía	Llamarlo hipomanía
Euforia tras iniciar ISRS	Suspender; es bipolar	Subir la dosis
Depresión en bipolar	Quetiapina o lamotrigina	ISRS solo

REGLA DE ORO **Un episodio maníaco: bipolar I** — Manía: 7 días, psicosis o deterioro

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, pregunta **18** (pág. 10) · solucionario pág. 24.

Clase 17.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS

17.3 Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

5.01.2.001 Conducta suicida — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Conducta suicida · Intervención en crisis · Intento de suicidio en niños y adolescentes · Ideación suicida

LO QUE TE PREGUNTAN

- El antecedente de intento suicida previo es el factor de riesgo independiente más potente para suicidio consumado a largo plazo.
- Preguntar directamente y de forma empática sobre la presencia de ideas, planes y métodos suicidas es obligatorio y NO induce el suicidio.
- En Chile, los hombres se suicidan con una frecuencia **4 a 5 veces** mayor que las mujeres debido a la elección de métodos más letales (ahorcamiento, armas de fuego).
- **La escala SAD PERSONS orienta la gravedad clínica**: puntajes **≥ 7 puntos** indican riesgo severo y exigen hospitalización psiquiátrica inmediata.
- Todo paciente con intento suicida reciente o plan estructurado activo debe permanecer con acompañamiento visual 1 a 1 permanente.
- El Carbonato de Litio y la Clozapina son los únicos dos fármacos que han demostrado reducir la mortalidad por suicidio en ensayos clínicos controlados.

ALGORITMO · RIESGO SUICIDA: DE LA IDEACIÓN A LA DECISIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

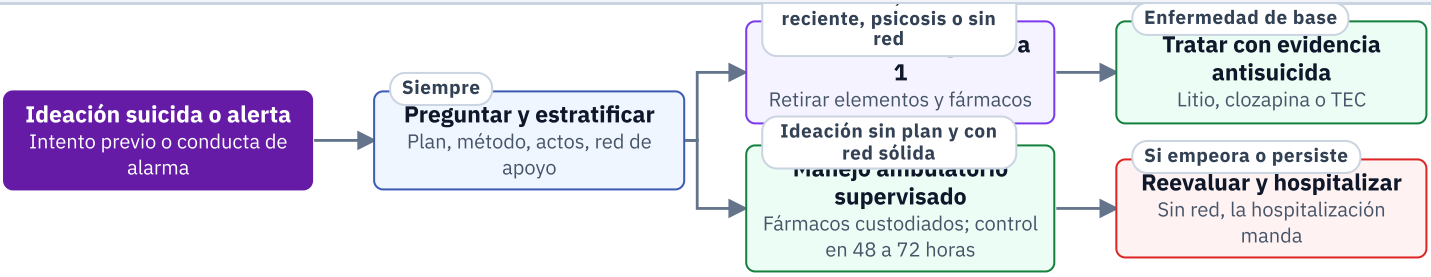


TABLA 17.3 · FACTORES DE RIESGO SUICIDA, DESENCADENANTES AGUDOS Y FACTORES PROTECTORES

CATEGORÍA	FACTORES DE ALTO RIESGO	SEÑALES DE ALARMA INMINENTE	FACTORES PROTECTORES FUERTES
Sociodemográficos	Hombres, > 65 años o 15-24 años, viudos, desempleados, aislamiento	Regalar posesiones queridas, cerrar cuentas bancarias, cartas de despedida	Hijos pequeños a cargo, red de apoyo extensa, empleo estable
Clínico-Psiquiátricos	Intento previo (factor N° 1), depresión melancólica, trastorno bipolar, adicciones	Desesperanza extrema, insomnio refractario, calma repentina sospechosa	Buena adherencia a tratamiento psiquiátrico, alianza terapéutica sólida
Psicopatológicos	Impulsividad alta, agitación, delirios de culpa/ruina, alucinaciones de comando	Declaración explícita de método con acceso a armas o pastillas	Creencias religiosas/morales firmes contrarias al suicidio
Biológicos / Médicos	Dolor crónico intratable, cáncer terminal, diagnóstico reciente de VIH o ELA	Intoxicación aguda por alcohol que desinhibe la barrera inhibitoria	Capacidad de resolución de problemas, proyectos futuros viables

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Sospecha de ideas suicidas	Preguntar directo	Evitar el tema
Intento previo	Riesgo alto de entrada	Minimizarlo por antiguo
Plan, método y carta de despedida	Hospitalizar, vigilar 1 a 1	Alta con familiar

REGLA DE ORO **Preguntar directo no induce** — Ideación, plan, método, actos

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, pregunta **2** (pág. 8) · solucionario pág. 22.

Clase 17.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS

17.4 Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.007 **Primer episodio depresivo** — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- El "Baby blues" o tristeza posparto inicia en los primeros **3 a 5 días** y se resuelve espontáneamente antes de las **2 semanas** sin necesidad de fármacos.
- La Depresión Posparto se pesquisa universalmente en APS mediante la Escala de Edimburgo (EPDS); un puntaje **≥ 10 puntos** exige confirmación y manejo activo bajo GES N° 21.
- Sertralina es el antidepresivo de elección durante la lactancia materna por su baja excreción en leche y excelente perfil de seguridad en el lactante.
- Paroxetina es una alternativa segura en lactancia, mientras que Fluoxetina se evita como primera opción por su larga vida media y metabolitos activos.
- La Psicosis Puerperal es una emergencia psiquiátrica absoluta con riesgo inminente de infanticidio y suicidio que exige hospitalización inmediata y separación protegida supervisada.

ALGORITMO · PUÉRPERA CON CAMBIOS DEL ÁNIMO: DE LA SOSPECHA A LA CONDUCTA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

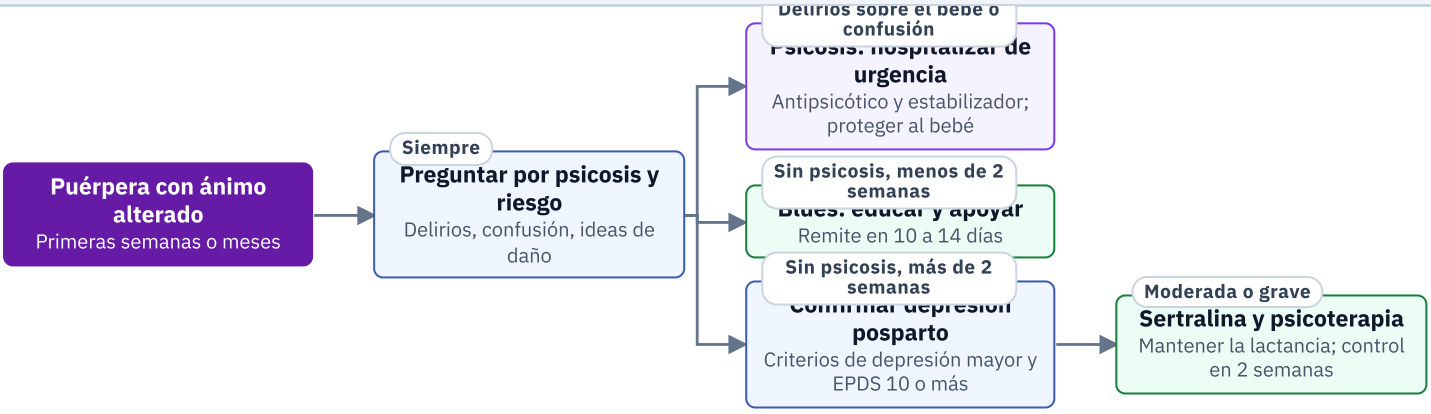


TABLA 17.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DISFORIA PUERPERAL (BLUES) VS DEPRESIÓN POSPARTO VS PSICOSIS PUERPERAL

CARACTERÍSTICA	DISFORIA PUERPERAL ("BLUES")	DEPRESIÓN POSPARTO (DPP)	PSICOSIS PUERPERAL
Prevalencia	50 – 80% de las madres	10 – 15% de las madres	0.1 – 0.2% (1-2 por 1.000 partos)
Inicio temporal	Precoz: 3.º a 5.º día postparto	2.ª a 6.ª semana (hasta 1 año)	Hiperagudo: 3.º a 14.º día postparto
Clínica cardinal	Labilidad emocional, llanto, fatiga	Anhedonia, culpa, desapego, tristeza	Delirios sobre el bebé, confusión, alucinaciones
Vínculo con el bebé	Preservado y afectuoso	Dificultoso, ambivalente, culpa	Ruptura grave · RIESGO DE INFANTICIDIO
Evolución y manejo	Autolimitado (< 14 días) · Apoyo familiar	Persistente · ISRS (Sertralina) + TCC	EMERGENCIA MÉDICA · Hospitalización inmediata + TEC/Antipsicóticos

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Llanto fácil, día 5, vínculo bueno	Educar y apoyar	Dar antidepresivo
Anhedonia y culpa a las 6 semanas	Depresión posparto: tratar	Decir que es el blues
Depresión posparto y lactancia	Sertralina y seguir amamantando	Suspender la lactancia

REGLA DE ORO **Blues: día 3 a 5; breve** — Vínculo preservado; sin fármacos

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Psiquiatría General**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 17.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS

17.5 Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.004 Trastorno de adaptación — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Trastornos somatomorfos

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Trastorno Adaptativo inicia dentro de los **3 meses** posteriores a un estresor biográfico identificable y se resuelve en menos de **6 meses** tras el fin del estresor.
- Los síntomas del Trastorno Adaptativo no alcanzan el umbral diagnóstico de 5 criterios de un Episodio Depresivo Mayor.
- El tratamiento de elección del Trastorno Adaptativo es la psicoterapia breve; los psicofármacos NO son la primera línea y no deben indicarse rutinariamente.
- La Distimia (Trastorno Depresivo Persistente) exige al menos **2 años** de ánimo depresivo continuo en adultos (al menos 1 año en niños y adolescentes).
- En la distimia, el paciente no permanece más de **2 meses** consecutivos sin síntomas durante el período de **2 años**.
- Depresión doble es la concurrencia de un Episodio Depresivo Mayor agudo sobreimpuesto a una Distimia crónica preexistente.

ALGORITMO · CUADRO DEPRESIVO: ADAPTATIVO, DISTIMIA O DEPRESIÓN MAYOR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

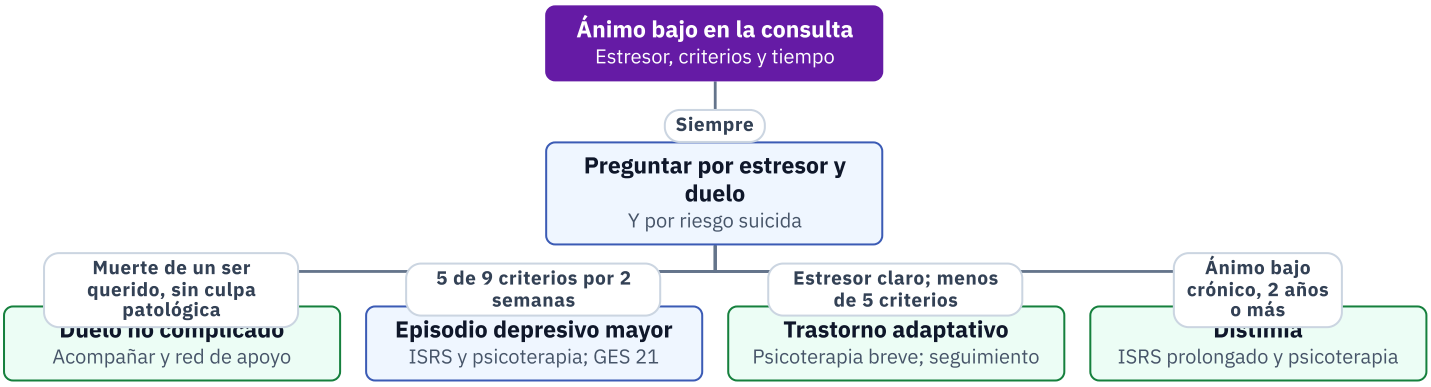


TABLA 17.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: TRASTORNO ADAPTATIVO VS DISTIMIA VS DEPRESIÓN MAYOR VS DUELO NORMAL

ENTIDAD CLÍNICA	DESENCADENANTE	DURACIÓN TEMPORAL	GRAVEDAD / CRITERIOS DSM-5	TRATAMIENTO PRINCIPAL
Trastorno Adaptativo	Estresor identificable previo (< 3 meses)	< 6 meses tras cese del estresor	Malestar desproporcionado pero < 5 criterios TDM	Psicoterapia focalizada · No requiere ISRS
Distimia (T. Dep. Persistente)	Habitualmente insidioso / biológico	≥ 2 años continuos (≥ 1 año en niños)	Subumbral a TDM pero persistente crónico	ISRS (Sertralina/Escitalopram) + Psicoterapia
Episodio Depresivo Mayor	Variable (puede ser endógeno o reactivo)	≥ 2 semanas consecutivas	≥ 5 de 9 criterios con disfunción marcada	ISRS de 1.ª línea + Psicoterapia (GES N° 21)
Duelo Normal / No Complicado	Fallecimiento de ser querido	Meses (picos ante fechas conmemorativas)	Tristeza con autoestima conservada; olas de dolor	Acompañamiento empático y red de apoyo

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Estresor claro; conserva el disfrute	Psicoterapia breve	Iniciar antidepresivo
Adaptativo que no mejora	Reevaluar: ¿depresión?	Seguir igual sin revisar
Ánimo bajo de más de 2 años	Distimia: ISRS y TCC	Solo reposo o adaptativo

REGLA DE ORO **Estresor, menos de 5 criterios** — Dentro de 3 meses; termina en 6

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **21–22** (pág. 11) · solucionario pág. 25.

Clase 17.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA

17.6 Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS

★★★ PRIORIDAD ALTA
20 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.001 Trastorno de pánico con o sin agorafobia — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Estudio de hormonas tiroídeas

LO QUE TE PREGUNTAN

- El ataque de pánico se caracteriza por inicio brusco y alcance de intensidad máxima en menos de **10 minutos**, acompañado de miedo inminente a morir o volverse loco.
- En todo primer episodio de pánico es mandatorio descartar patología médica mediante examen físico y Electrocardiograma de 12 derivaciones.
- El Trastorno de Pánico exige ataques recurrentes e imprevistos seguidos de al menos **1 mes** de ansiedad anticipatoria o evitación conductual.
- Agorafobia es el temor a encontrarse en lugares o situaciones donde escapar sea difícil o no haya ayuda disponible ante una crisis de pánico.
- Las benzodiacepinas (Clonazepam o Lorazepam) se usan exclusivamente como rescate agudo o terapia puente en las primeras **2 a 4 semanas**.

ALGORITMO · SÍNTOMAS DE PÁNICO: DE LA URGENCIA AL TRATAMIENTO DE FONDO

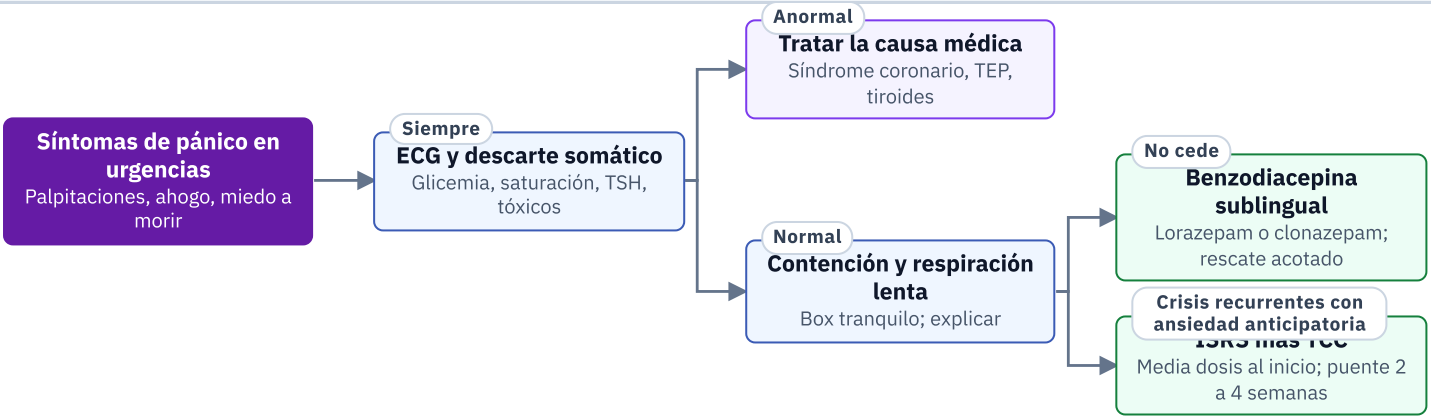


TABLA 17.6 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ATAQUE DE PÁNICO: CAUSAS PSIQUIÁTRICAS VS MÉDICAS

ETIOLOGÍA / CUADRO	HALLAZGOS CLÍNICOS CLAVE	EXAMEN DE DESCARTE INMEDIATO	DIFERENCIA CRÍTICA CON PÁNICO PRIMARIO
Trastorno de Pánico Primario	Pico en < 10 min, miedo a morir/volverse loco, temblor, desrealización	ECG normal, laboratorio basal normal	Ataques imprevistos recurrentes con ansiedad anticipatoria posterior
Síndrome Coronario Agudo (SCA)	Dolor retroesternal opresivo irradiado a mandíbula/brazo, diaforesis fría	ECG de 12 derivaciones + Troponinas seriadas	Dolor se prolonga > 20-30 min y suele asociarse a esfuerzo o factores CV
Tromboembolismo Pulmonar	Disnea súbita inexplicable, dolor pleurítico, taquipnea, taquicardia	AngioTAC de tórax / Dímero D	Hipoxemia marcada en gases arteriales (SatO2 < 90%)
Feocromocitoma	Tríada clásica: cefalea paroxística + diaforesis + palpitaciones con HTA	Metanefrinas libres en plasma o fraccionadas en orina 24 h	Crisis de hipertensión arterial maligna paroxística muy severa (> 200/120)
Hipertiroidismo / Tirotoxicosis	Pérdida de peso, temblor fino distal persistente, bocio, intolerancia al calor	TSH baja (< 0.01) y T4 libre elevada	Taquicardia y ansiedad sostenidas que no remiten entre episodios

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Primer episodio con dolor torácico	ECG y descartar lo somático	Rotular ansiedad sin examinar
Crisis aguda, ECG normal	Contención y lorazepam SL	Adenosina, morfina o intubar
Pánico recurrente	ISRS más TCC	Benzodiacepina en monoterapia

REGLA DE ORO **Crisis recurrentes más un mes** — Miedo a nuevas crisis o evitación

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **23–29** (págs. 11–12) · solucionario págs. 25–26.

Clase 17.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA

17.7 Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
12 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.036 Trastorno de ansiedad generalizada — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Trastornos fóbicos (fobia social y fobia específica) · Trastornos de ansiedad generalizada

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) exige preocupación excesiva e incontrolable por múltiples temas presente por **≥ 6 meses**.
- La tensión muscular marcada (bruxismo, contracturas cervicales) es el síntoma somático distintivo del TAG.
- Los ISRS (Escitalopram, Sertralina) y los IRSN (Venlafaxina) son los fármacos de primera elección para el TAG.
- La Fobia Social se define por el miedo irracional a la evaluación negativa, el escrutinio o la vergüenza en público.
- En la fobia social circunscrita a hablar en público (pánico escénico), el fármaco de rescate es Propranolol **10 a 40 mg** VO **1 hora** antes.
- **Trampa del examen**: Las benzodiacepinas no curan el TAG y están formalmente contraindicadas como terapia de mantenimiento crónico debido a su alto potencial de dependencia, caídas y deterioro cognitivo.

ALGORITMO · ANSIEDAD CRÓNICA: DEL SÍNTOMA AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

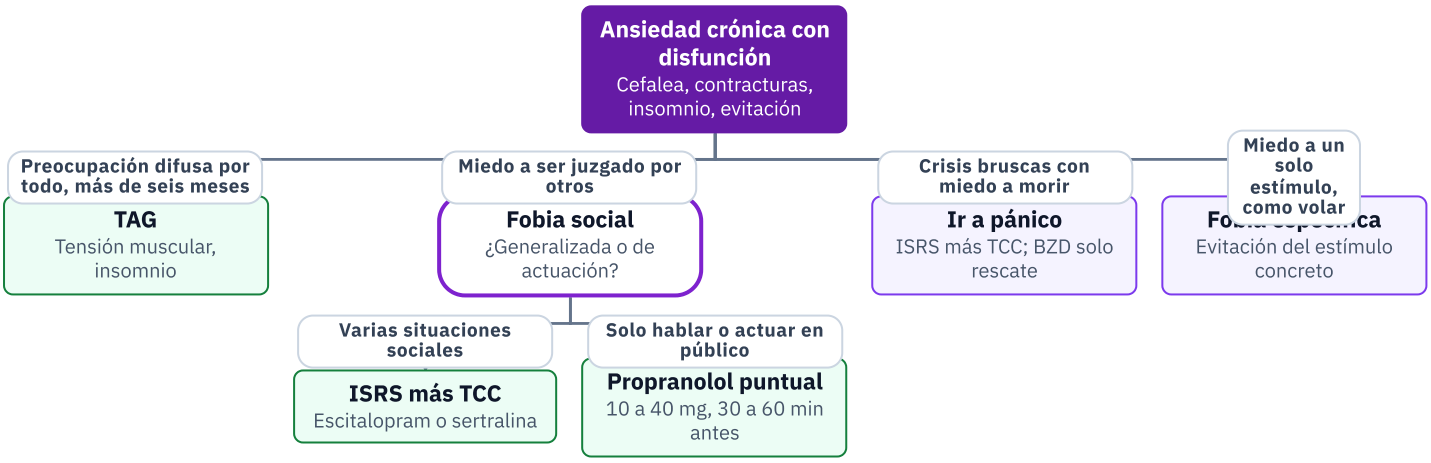


TABLA 17.7 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: TAG VS FOBIA SOCIAL VS TRASTORNO DE PÁNICO

CRITERIO CLÍNICO	TRASTORNO ANSIEDAD GENERALIZADA (TAG)	FOBIA SOCIAL (ANSIEDAD SOCIAL)	TRASTORNO DE PÁNICO
Foco de la ansiedad	Preocupación difusa por múltiples temas cotidianos	Miedo al escrutinio, vergüenza y evaluación ajena	Miedo paroxístico a morir o volverse loco
Curso temporal	Continuo y flotante (mínimo 6 meses)	Gatillado por exposición a situaciones sociales	Paroxístico en crisis (< 10 min de pico)
Síntomas cardinales	Tensión muscular, bruxismo, fatiga, insomnio	Rubor facial, temblor de voz, sudoración, tartamudeo	Palpitaciones masivas, opresión precordial, asfixia
Tratamiento de elección	ISRS (Escitalopram/Sertralina) + TCC	ISRS (generalizada) o Propranolol (actuación)	ISRS + TCC (BZD solo rescate agudo)
Error farmacológico	Prescribir Clonazepam o Diazepam crónico indefinido	No indicar Propranolol previo en pánico escénico	Asumir infarto y no iniciar ISRS tras descarte

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Preocupación múltiple, 6 meses	TAG: ISRS más TCC	Clonazepam indefinido
Evita presentaciones y reuniones	Fobia social: ISRS	Propranolol o alprazolam diario
Solo teme exponer en público	Propranolol antes del evento	Antidepresivo continuo de entrada

REGLA DE ORO **TAG: 6 meses, 3 síntomas** — Preocupación múltiple, tensión muscular

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **30–33** (págs. 12–13) · solucionario págs. 26–27.

Clase 17.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA

17.8 Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
11 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.002 Trastorno obsesivo compulsivo — Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- El TOC se define por la presencia de obsesiones (pensamientos intrusivos egodistónicos) y compulsiones (actos para neutralizar la angustia) que consumen > **1 hora**/día.
- **Diferencia cardinal**: En el TOC el síntoma es egodistónico (el paciente reconoce lo absurdo y sufre); en el TPOC es egosintónico (cree que su perfeccionismo es virtuoso).
- La psicoterapia de elección indiscutida para el TOC es la Terapia Cognitivo-Conductual con Exposición y Prevención de Respuesta (EPR).
- **Farmacoterapia**: Los ISRS (Sertralina, Fluoxetina) son la 1.ª línea, pero requieren dosis más elevadas que en depresión (ej. Sertralina **200 mg**) y latencias de **8 a 12 semanas**.
- Clomipramina (tricíclico) es el fármaco más eficaz de segunda línea en casos resistentes.
- **Trampa del examen**: No confundir TOC con Trastorno de la Personalidad Obsesivo-Compulsivo; el paciente con TPOC no tiene obsesiones intrusivas ni rituales de lavado.

ALGORITMO · OBSESIONES Y COMPULSIONES: DEL DIAGNÓSTICO AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

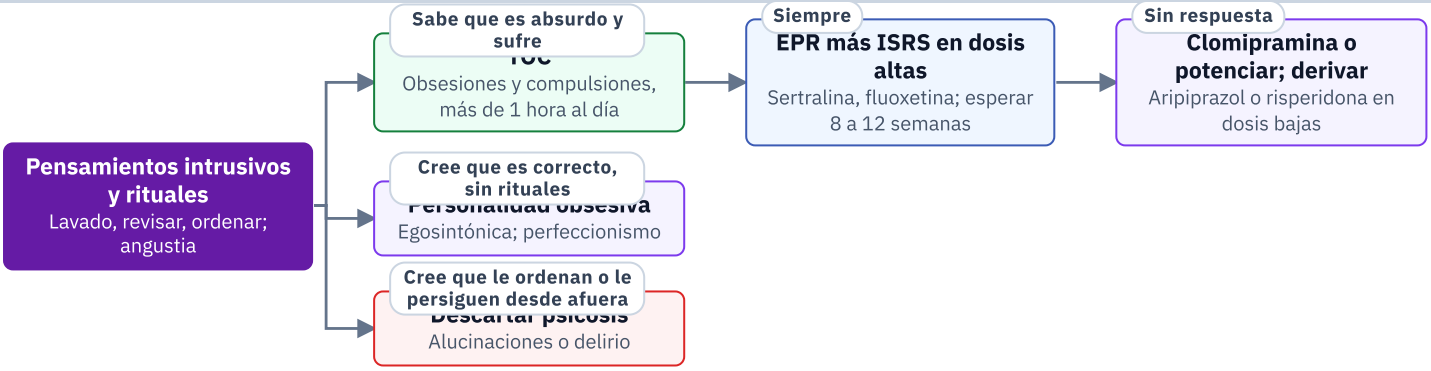


TABLA 17.8 · DIFERENCIACIÓN CONCEPTUAL: TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (TOC) VS PERSONALIDAD OBSESIVO-COMPULSIVA (TPOC)

CARACTERÍSTICA	TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (TOC)	TRASTORNO PERSONALIDAD OBSESIVO-COMPULSIVO (TPOC)
Sintonía con el yo	EGODISTÓNICO: el síntoma es ajeno y causa gran sufrimiento	EGOSINTÓNICO: el sujeto considera que su conducta es correcta
Presencia de obsesiones	SIEMPRE presentes (ideas intrusivas, indeseadas, absurdas)	AUSENTES (no hay obsesiones intrusivas)
Presencia de rituales	SIEMPRE presentes (compulsiones para calmar la angustia)	AUSENTES (no hay rituales estereotipados)
Consumo de tiempo	Severo: consume horas al día limpiando, ordenando o contando	Dedicación excesiva al trabajo por perfeccionismo y minuciosidad
Tratamiento de elección	ISRS en dosis altas + TCC con Exposición y Prevención de Respuesta	Psicoterapia individual psicodinámica o cognitiva

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Sabe que es absurdo, igual lo hace	TOC	Psicosis o delirio
Imágenes de dañar a un hijo, con angustia	TOC; evaluar riesgo suicida	Depresión psicótica o TEPT
Miedo a ser pedófilo, reza y evita	TOC	Parafilia

REGLA DE ORO **Obsesión más compulsión** — Más de 1 hora al día; egodistónico

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **34–36** (pág. 13) · solucionario pág. 27.

Clase 17.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA

17.9 Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
16 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.006 **Trastorno por estrés postraumático** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Trastorno agudo por estrés · Trastornos disociativos

LO QUE TE PREGUNTAN

- **La frontera temporal diagnóstica es 1 mes**: síntomas entre **3 días** y **1 mes** = Estrés Agudo; síntomas > **1 mes** = TEPT.
- **Los 4 clústeres del TEPT son**: 1) Intrusión (flashbacks, pesadillas); 2) Evitación; 3) Alteraciones cognitivas/ánimo negativo; y 4) Hiperalerta.
- Los flashbacks son episodios disociativos donde el paciente siente y actúa como si el trauma estuviera ocurriendo nuevamente en el presente.
- Los ISRS (Sertralina y Paroxetina) son los psicofármacos de primera línea aprobados para el tratamiento del TEPT.
- La Prazosina (antagonista alfa-1) es el fármaco de elección para tratar las pesadillas traumáticas refractarias del TEPT.
- **Trampa del examen**: Las benzodiacepinas están contraindicadas como tratamiento del TEPT; no previenen el trastorno, interfieren con la psicoterapia de reprocesamiento y generan adicción.

ALGORITMO · TRAUMA: DEL TIEMPO TRANSCURRIDO AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 17.9 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: TRASTORNO DE ESTRÉS AGUDO VS TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (TEPT)

PARÁMETRO	TRASTORNO DE ESTRÉS AGUDO	TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (TEPT)
Duración temporal	3 días a 1 mes (máximo 30 días post-trauma)	Más de 1 mes (crónico si > 3 meses; de inicio retardado si > 6 meses)
Clínica predominante	Gran componente disociativo inicial, aturdimiento, desrealización	Los 4 clústeres: Intrusión, Evitación, Cognición/ánimo negativo, Hiperalerta
Intervención inmediata	Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) y red familiar	TCC centrada en trauma / EMDR + Farmacoterapia de 1.ª línea
Farmacoterapia inicial	Generalmente NO requiere psicofármacos; NO dar BZD	ISRS (Sertralina / Paroxetina) + Prazosina si hay pesadillas
Error frecuente	Prescribir Clonazepam o forzar un debriefing traumático	Minimizar los flashbacks como si fueran "recuerdos normales"

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Trauma hace 2 semanas, hiperalerta	Estrés agudo	TEPT
Trauma hace 8 meses, evita y pesadillas	TEPT	Estrés agudo o adaptativo
Estresor sin intrusión ni hiperalerta	Trastorno adaptativo	Estrés agudo

REGLA DE ORO **Trauma más tiempo** — 3 días a 1 mes agudo; luego TEPT

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **47–54** (págs. 15–16) · solucionario págs. 29–30.

Clase 17.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

17.10 Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES

★★★ PRIORIDAD ALTA
34 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.010 **Esquizofrenia y otros trastornos psicòticos** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Examen físico y neurológico: control de neurolépticos de depósito

LO QUE TE PREGUNTAN

- El diagnóstico de Esquizofrenia según DSM-5 exige al menos **6 meses** de evolución total continua con al menos **1 mes** de síntomas activos (delirios, alucinaciones o habla desorganizada).
- En Chile, el Primer Episodio de Esquizofrenia en personas de **15 años** y más está garantizado por el GES N° 34 (confirmación en **≤ 20 días** e inicio de terapia en **≤ 24 h** post-confirmación).
- Todo primer episodio psicótico exige descarte toxicológico en orina y neuroimagen (TAC de encéfalo) para descartar causas secundarias.
- Los antipsicóticos de segunda generación (Risperidona, Olanzapina, Quetiapina, Aripiprazol) son la primera línea de tratamiento farmacológico.
- La distonía aguda (espasmo ocular o cervical en las primeras **48 h**) se trata de urgencia con Biperideno **5 mg** IM o EV.



CRISIS OCULÓGIRA
The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 506

ALGORITMO · PRIMER EPISODIO PSICÓTICO: DEL ESTUDIO AL SEGUIMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

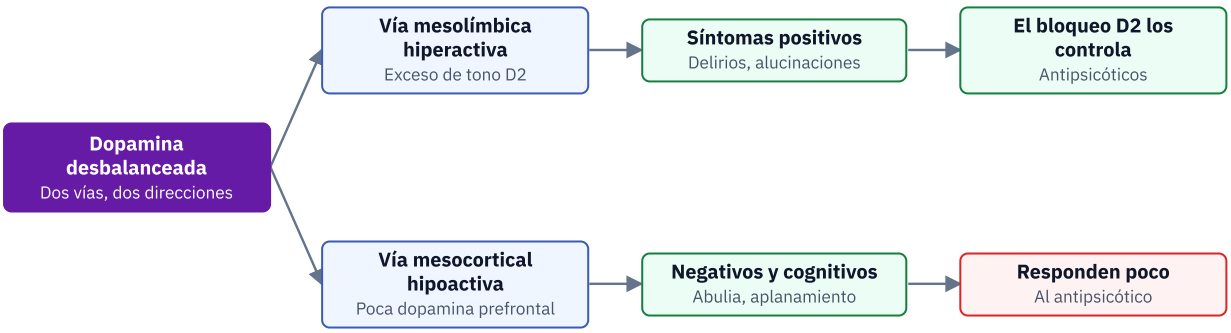


TABLA 17.10 · SÍNTOMAS POSITIVOS VS SÍNTOMAS NEGATIVOS EN ESQUIZOFRENIA Y VÍAS NEUROBIOLÓGICAS

CATEGORÍA SINTOMÁTICA	MANIFESTACIONES CLÍNICAS CLAVE	VÍA DOPAMINÉRGICA COMPROMETIDA	RESPUESTA FARMACOLÓGICA
Síntomas Positivos	Delirios (persecución, perjuicio, místicos), alucinaciones auditivas, habla desorganizada	Hiperactividad mesolímbica (exceso D2)	Excelente respuesta a antipsicóticos (bloqueo D2)
Síntomas Negativos	Aplanamiento afectivo, abulia (falta de voluntad), alogia (pobreza del habla), anhedonia	Hipoactividad mesocortical prefrontal	Pobre respuesta a antipsicóticos; mejor con atípicos y psicosocial
Síntomas Cognitivos	Déficit de memoria de trabajo, atención ejecutiva alterada, procesamiento lento	Disfunción cortical prefrontal y del hipocampo	Rehabilitación cognitiva; no remiten plenamente con fármacos
Síntomas Afectivos	Disforia, depresión post-psicótica, riesgo suicida elevado	Disfunción límbico-cortical compleja	Manejo con antidepresivos cautelosos o estabilizadores

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Primer episodio con tóxicos negativos	Notificar GES, derivar, atípico	Esperar o dar solo psicoterapia
Delirios y voces resueltos; sigue apático	Negativos: apoyo psicosocial	Subir mucho el antipsicótico
Espasmo de cuello a las 24 horas	Distonía: biperideno	Pensar en conversión o convulsión

REGLA DE ORO **Positivos, negativos y 6 meses** — Uno entre delirio, alucinación, habla

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **38–44** (págs. 13–14) · solucionario págs. 28–29.

Clase 17.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

17.11 Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma

★★★ PRIORIDAD ALTA
35 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.010 Esquizofrenia y otros trastornos psicòticos — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Hemograma

LO QUE TE PREGUNTAN

- Esquizofrenia refractaria se define por el fracaso a **≥ 2 ensayos** con antipsicóticos a dosis plenas por **≥ 6 semanas** (al menos un atípico).
- La Clozapina es el fármaco de elección indiscutido en esquizofrenia refractaria y en psicosis con conducta suicida persistente.
- **Calendario de hemogramas con clozapina**: semanal durante los primeros **6 meses**, quincenal de los **6 a 12 meses**, y mensual de por vida.
- Si el RAN cae por debajo de 1.000/mm³, se debe suspender la clozapina de inmediato y queda formalmente proscrita la reexposición de por vida.
- La Clozapina no produce síntomas extrapiramidales ni discinesia tardía, pero puede causar miocarditis, convulsiones e íleo paralítico fatal.
- **Trampa del examen**: Ante un RAN < 1.000/mm³ en un paciente con Clozapina, jamás bajar la dosis ni repetir el examen en una semana sin suspender; la suspensión inmediata es la única conducta correcta.

ALGORITMO · CLOZAPINA: DE LA INDICACIÓN AL CONTROL DEL RAN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

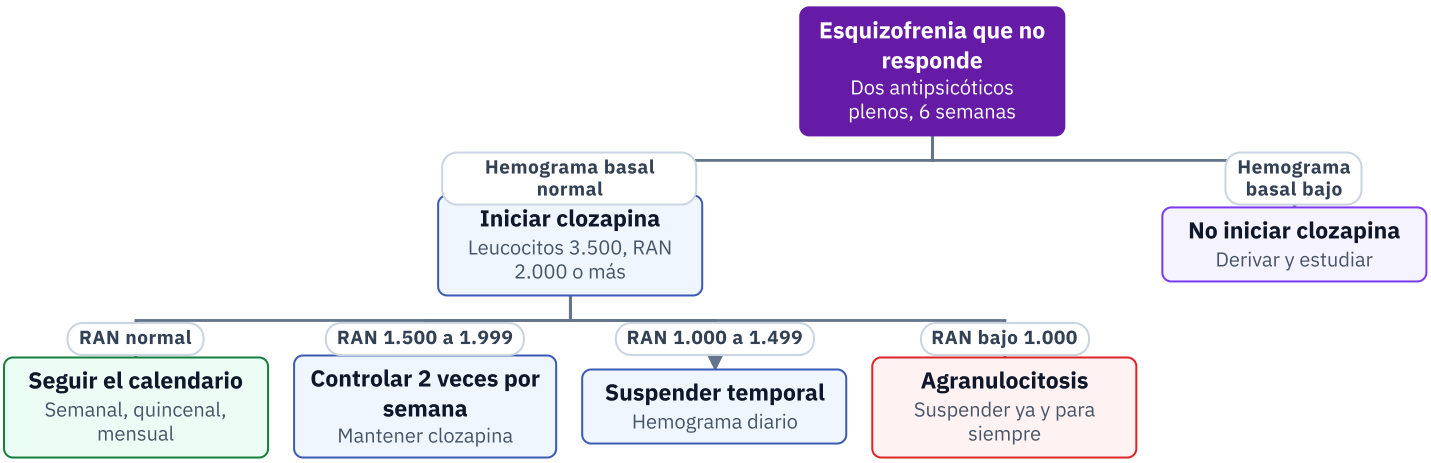


TABLA 17.11 · PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y MONITOREO HEMATOLÓGICO DE CLOZAPINA SEGÚN NIVELES DE RAN

NIVEL DE RAN (NEUTRÓFILOS)	ESTADO HEMATOLÓGICO	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA	POSIBILIDAD DE REEXPOSICIÓN
RAN ≥ 2.000/mm³	Normal / Seguro	Continuar tratamiento según calendario habitual (semanal -> quincenal -> mensual)	Uso continuado autorizado
RAN 1.500 – 1.999/mm³	Neutropenia Leve	Continuar clozapina pero intensificar controles a dos veces por semana hasta normalizar	Permitida bajo vigilancia estrecha
RAN 1.000 – 1.499/mm³	Neutropenia Moderada	Suspender temporalmente clozapina · Hemograma diario · Reanudar al superar 1.500	Permitida tras recuperación completa
RAN < 1.000/mm³	AGRANULOCITOSIS SEVERA	SUSPENSIÓN INMEDIATA Y DEFINITIVA · Aislamiento protector · G-CSF	FORMALMENTE PROHIBIDA DE POR VIDA

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
2 antipsicóticos plenos, 6 semanas, sin respuesta	Clozapina con hemograma	Subir una tercera vez el mismo fármaco
Hemograma: semanal, quincenal, mensual	Seis meses, seis meses, luego de por vida	Cambiar los plazos
RAN de 1.200	Suspender temporal; hemograma diario	Tratarlo como agranulocitosis definitiva

REGLA DE ORO **Refractaria: 2 fármacos, 6 semanas** — Uno atípico, adherencia verificada

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **45–46** (pág. 15) · solucionario pág. 29.

Clase 17.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

17.12 Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve

★★★ PRIORIDAD ALTA
34 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.010 Esquizofrenia y otros trastornos psicòticos — Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Trastorno Psicótico Breve dura entre **1 día** y menos de **1 mes**, resolviendo con restitución completa ad integrum.
- El Trastorno Esquizofreniforme tiene una duración de entre 1 y **6 meses**; si los síntomas superan los **6 meses** se diagnostica Esquizofrenia.
- El Trastorno Delirante Crónico exige delirios no bizarros de **≥ 1 mes** de duración, con preservación de la funcionalidad global fuera del núcleo delirante.
- En el trastorno delirante NO hay alucinaciones prominentes, ni lenguaje desorganizado, ni síntomas negativos.
- El subtipo celotípico (Síndrome de Otelo) es de muy alto riesgo de violencia física hacia la pareja y exige evaluación prioritaria de seguridad.
- **Regla relacional**: Nunca confrontar directamente el delirio ni validar su veracidad; adoptar una postura empática enfocada en el malestar subjetivo del paciente.

ALGORITMO · PSICOSIS NO ESQUIZOFRÉNICAS: DEL RELOJ AL DIAGNÓSTICO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

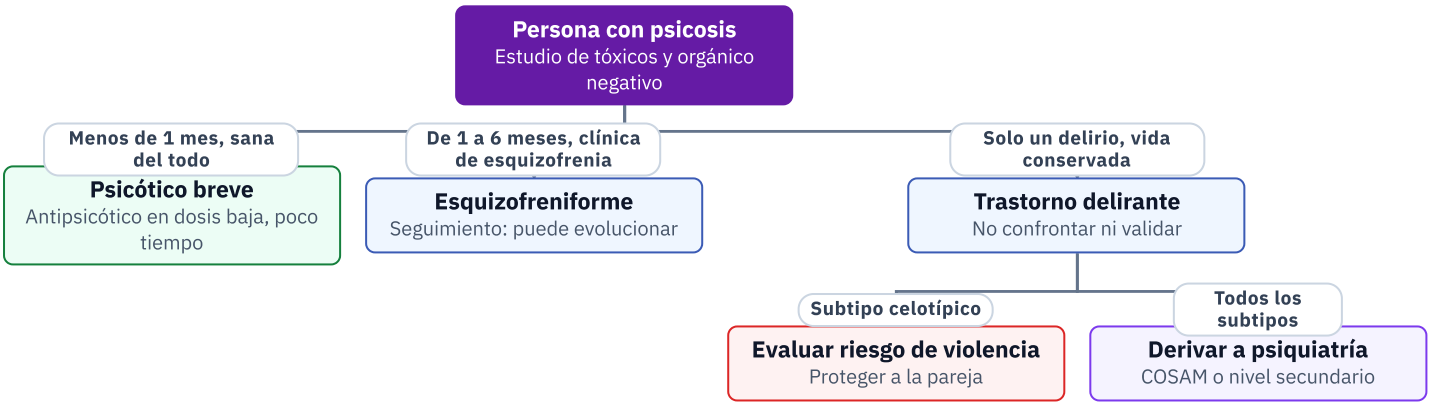


TABLA 17.12 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CRONOLÓGICO Y CLÍNICO DEL ESPECTRO PSICÓTICO

TRASTORNO PSICÓTICO	DURACIÓN TEMPORAL REQUERIDA	TIPO DE DELIRIO Y SÍNTOMAS	NIVEL DE DETERIORO FUNCIONAL	PRONÓSTICO GLOBAL
Trastorno Psicótico Breve	≥ 1 día y < 1 mes (< 30 días)	Florido, polimorfo, reactivo a estresor	Grave agudo pero con restitución completa ad integrum	Excelente
Trastorno Esquizofreniforme	≥ 1 mes y < 6 meses	Idéntico a esquizofrenia (positivos y negativos)	Moderado a severo durante el episodio	Reservado (60-80% progresa a esquizofrenia)
Esquizofrenia	≥ 6 meses continuos (≥ 1 mes activo)	Bizarro, delirios de influencia, alucinaciones auditivas	Severo, progresivo, afecto plano y abulia	Crónico / Manejo de rehabilitación GES
Trastorno Delirante Crónico	≥ 1 mes (suele llevar años)	No bizarro, bien estructurado y verosímil (celos, daño)	CONSERVADO en áreas no vinculadas al delirio	Crónico refractario a psicofármacos

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Trabaja bien, convicción fija y sin voces	Trastorno delirante	Esquizofrenia
Convicción de infidelidad sin pruebas	Delirante celotípico; evaluar riesgo	Trastorno obsesivo o celos normales
Convicción de enfermedad que los exámenes niegan	Delirante somático	Hipocondría o demencia

REGLA DE ORO **Breve: menos de 1 mes** — Sana del todo; esquizofreniforme: 1 a 6 meses

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **56–57** (págs. 16–17) · solucionario pág. 30.

Clase 17.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

17.13 Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
5 preguntas reales 2013–2025

5.01.5.002 Examen físico y neurológico: control de neurolépticos de depósito — Realizar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **El Síndrome Neuroléptico Maligno se caracteriza por la tétrada**: hipertermia, rigidez muscular en "caño de plomo", inestabilidad autonómica y alteración del sensorio.
- La elevación masiva de la CPK (> 1.000 a > **10.000 UI**/L) secundaria a rabdomiólisis es el hallazgo bioquímico distintivo del SNM.
- **Diferencia cardinal con el Síndrome Serotoninérgico**: el SNM cursa con rigidez en caño de plomo e hiporreflexia; el serotoninérgico cursa con hiperreflexia marcada y clonus.
- La primera medida terapéutica obligatoria y vital es la suspensión inmediata de todos los fármacos antipsicóticos.
- La hidratación endovenosa masiva con suero salino para forzar diuresis (> **2 mL/kg**/h) es indispensable para evitar la necrosis tubular aguda por mioglobinuria.

ALGORITMO · SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO: DEL EXAMEN A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

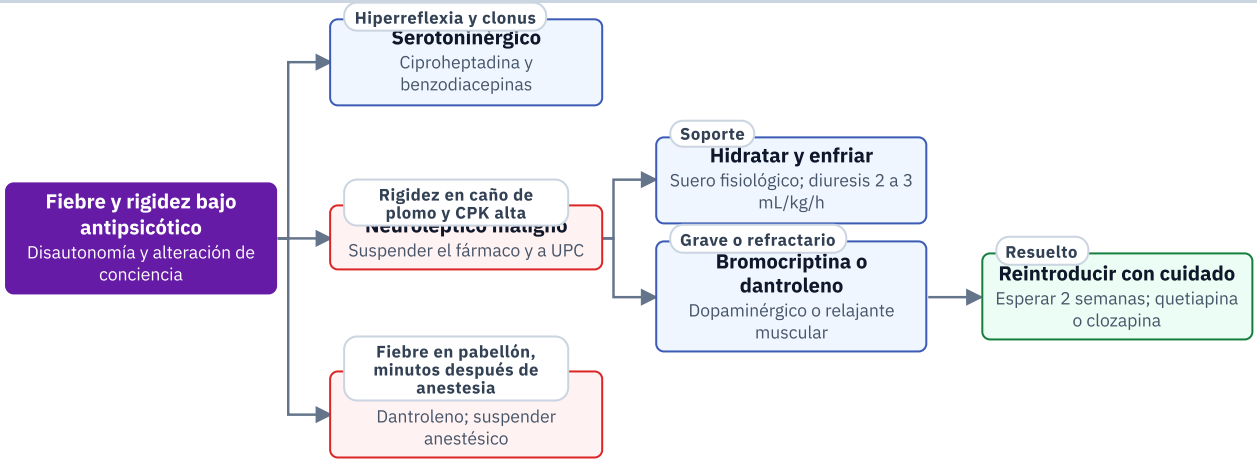


TABLA 17.13 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO: SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO VS SÍNDROME SEROTONINÉRGICO

CARACTERÍSTICA	SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO (SNM)	SÍNDROME SEROTONINÉRGICO (CRITERIOS DE HUNTER)
Fármacos desencadenantes	Antipsicóticos (Haloperidol, Risperidona) · Retiro de Levodopa	ISRS, IRSN, Tramadol, Tricíclicos, IMAO, MDMA (éxtasis)
Comienzo temporal	Subagudo e insidioso (días a semanas post-cambio de dosis)	Hiperagudo (horas después de una coingesta o sobredosis)
Tono muscular	RIGIDEZ EN "CAÑO DE PLOMO" extrema, uniforme y generalizada	Rigidez leve a moderada (predomina en miembros inferiores)
Reflejos osteotendinosos	HIPORREFLEXIA o reflejos disminuidos por hipertonía plástica	HIPERREFLEXIA MARCADA Y CLONUS (espontáneo / inducible)
Pupilas y Gastrointestinal	Pupilas normales · Estreñimiento por anticolinérgicos	MIDRIASIS bilateral marcada · DIARREA profusa y borborigmos
Tratamiento específico	Dantroleno EV + Bromocriptina (agonista dopaminérgico)	Ciproheptadina (antagonista 5-HT2A) + Benzodiacepinas

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Fiebre, rigidez y CPK alta con haloperidol	Suspender y llevar a UPC	Subir el antipsicótico o dar antibiótico solo
Rigidez con hiperreflexia y clonus	Serotoninérgico: ciproheptadina	Dantroleno y bromocriptina
Fiebre alta sin respuesta a paracetamol	Enfriar físicamente	Insistir con antipiréticos

REGLA DE ORO **Fiebre, caño de plomo, disautonomía, conciencia** — Tras subir o iniciar un antipsicótico

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **58–61** (pág. 17) · solucionario pág. 31.

Clase 17.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

17.14 Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
8 preguntas reales 2013–2025

5.01.2.002 Agitación psicomotora — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Delirium

LO QUE TE PREGUNTAN

- En todo paciente agitado es obligatorio descartar primero causas orgánicas potencialmente reversibles: glicemia capilar (hipoglicemia) y oximetría (hipoxia).
- **El protocolo de contención es estrictamente escalonado**: 1) Verbal y ambiental; 2) Farmacológica; 3) Mecánica física de último recurso.
- La contención verbal exige mantener siempre la vía de escape despejada entre el médico y la puerta del box, sin acorralar al paciente.
- El esquema farmacológico intramuscular de primera elección en agitación aguda severa es la combinación de Haloperidol **5 mg** IM + Lorazepam **2 mg** IM.
- La combinación de Haloperidol con Lorazepam ofrece mayor rapidez de sedación, menor dosis requerida y prevención de la distonía aguda.

ALGORITMO · PACIENTE AGITADO: DE LA CAUSA A LA CONTENCIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

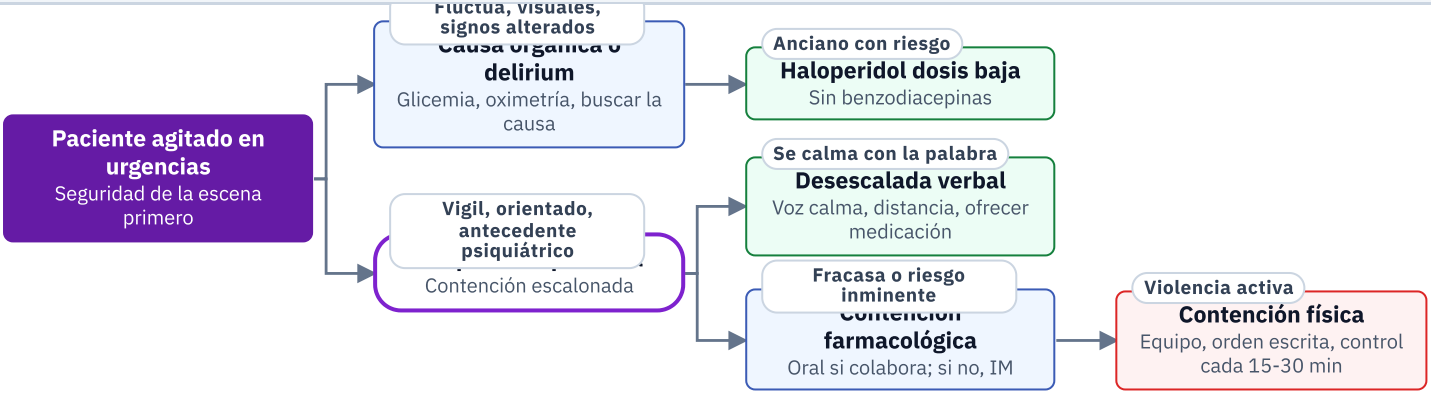


TABLA 17.14 · ETIOLOGÍA DE LA AGITACIÓN PSICOMOTORA: DIFERENCIAS ENTRE ORIGEN ORGÁNICO Y PSIQUIÁTRICO

PARÁMETRO CLÍNICO	AGITACIÓN DE CAUSA ORGÁNICA (DELIRIUM)	AGITACIÓN DE CAUSA PSIQUIÁTRICA PRIMARIA
Nivel de conciencia	FLUCTUANTE, confuso, desorientado témporo-espacialmente	VIGIL, lúcido, orientado en tiempo y espacio
Comienzo temporal	Agudo / Súbito (horas a días), empeora en la noche ("sundowning")	Insidioso o subagudo con antecedentes psiquiátricos previos
Alucinaciones	Predominantemente VISUALES o táctiles (zoopsias, sombras)	Predominantemente AUDITIVAS complejas o en tercera persona
Examen físico / Signos vitales	FRECUENTEMENTE ALTERADOS (fiebre, sudoración, taquicardia, focalidad)	Habitualmente normales salvo taquicardia por esfuerzo motor
Manejo prioritario	TRATAR LA CAUSA MÉDICA DE BASE (HGT, oxígeno, antibióticos, sonda)	Contención escalonada + Antipsicóticos / Benzodiacepinas

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Agitado y agresivo verbal, sin violencia física	Contención verbal y ambiental	Sujetar o inyectar de entrada
Agitación sin causa conocida	Glicemia y oximetría primero	Sedar sin descartar lo orgánico
Psicosis agitada que rechaza la vía oral	Haloperidol más lorazepam IM	Olanzapina IM más lorazepam IM

REGLA DE ORO **Glicemia y oximetría primero** — Delirium: tratar la causa

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **62–66** (págs. 17–18) · solucionario págs. 31–32.

Clase 17.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

17.19 Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
8 preguntas reales 2013–2025

5.01.3.001 **Clasificaciones en psiquiatría** — Conocimiento general

También: Higiene del sueño · Trastornos facticios · Nociones de psiquiatría forense

LO QUE TE PREGUNTAN

- El diagnóstico psiquiátrico es clínico y sindromático; la CIE-10 (F00-F99) es la clasificación oficial en Chile para ficha, GES y licencias, y el DSM-5 aporta los criterios.
- **Higiene del sueño**: horarios fijos, cama solo para dormir, sin siestas largas, cafeína ni alcohol; es la primera medida, antes de cualquier hipnótico.
- La TCC para insomnio es la primera línea del insomnio crónico; los hipnóticos se usan solo **2-4 semanas** y no se usa quetiapina para el insomnio simple.
- **Trastorno facticio**: produce síntomas de forma intencional para asumir el rol de enfermo, sin beneficio externo; la simulación sí tiene un motivo externo y no es enfermedad mental.
- Los trastornos somatomorfos y conversivos son involuntarios; el facticio impuesto a otro (cuidador a un niño) es abuso infantil y obliga a proteger y notificar.

ALGORITMO · SÍNTOMA SIN CAUSA ORGÁNICA: FACTICIO, SIMULACIÓN O SOMATOMORFO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

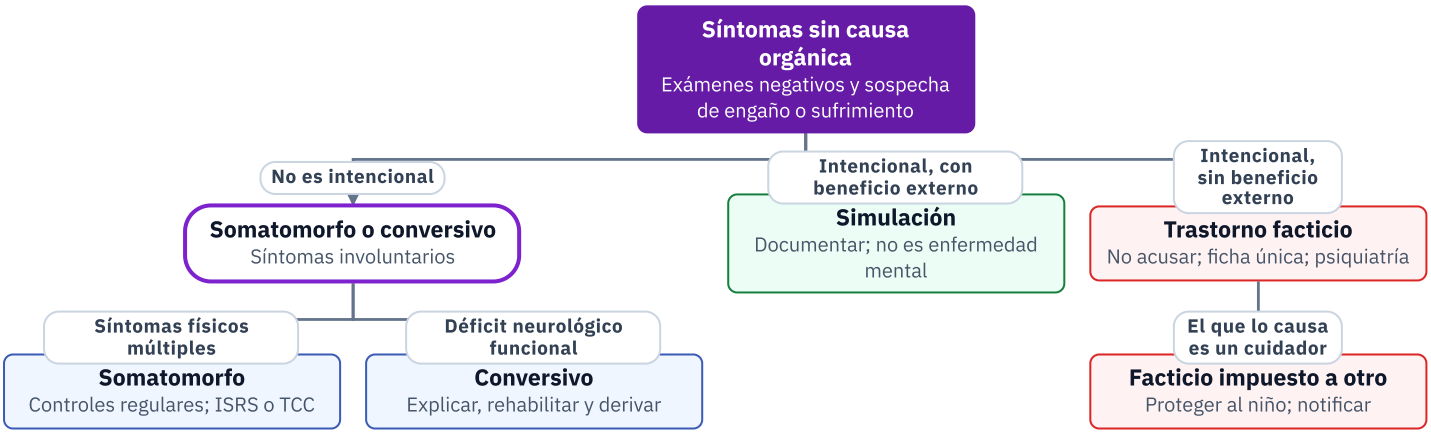


TABLA 17.19 · FACTICIO, SIMULACIÓN, SOMATOMORFO Y CONVERSIVO: CÓMO DISTINGUIRLOS

ENTIDAD	¿ES INTENCIONAL?	MOTIVACIÓN	CONDUCTA DEL MÉDICO GENERAL
Trastorno facticio	Sí, con engaño	Asumir el rol de enfermo (ganancia psicológica)	Evitar procedimientos, interconsulta psiquiátrica, no acusar
Simulación	Sí, consciente	Beneficio externo: licencia, dinero, drogas, evitar un castigo	Documentar objetivamente; no es enfermedad mental
Somatomorfo	No	Sufrimiento por síntomas físicos sin causa orgánica	Controles regulares, no repetir exámenes, ISRS/TCC
Conversivo	No	Déficit neurológico funcional ligado a un estrés	Explicar con claridad, rehabilitación, derivar
Facticio impuesto a otro	Sí, hacia un tercero	Rol de cuidador de un niño enfermo	Proteger al menor y notificar a la justicia de familia

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Registrar diagnóstico para licencia y GES	CIE-10 de la OMS	DSM-5 o una escala
Insomnio leve sin causa clara	Higiene del sueño	Zolpidem o quetiapina de entrada
Toma laxantes a escondidas, sin ganancia	Trastorno facticio	Simulación o conversivo

REGLA DE ORO **CIE-10: oficial en Chile** — DSM-5 aporta criterios

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Psiquiatría General**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 17.19 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

17.15 Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
12 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad · Causa líder de morbimortalidad psiquiátrica y urgencias toxicológicas en Chile

5.01.1.012 **Dependencia de alcohol** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Estado confusional agudo (alcohólico, tóxico metabólico) · Manifestaciones neurológicas de abuso de sustancias y alcohol · EBBA (Escala breve de Beber Anormal) · Déficit agudo de tiamina

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Encefalopatía de Wernicke es causada por déficit de tiamina (B1); su tríada clásica es oftalmoplejía (VI par), ataxia y confusión.
- **REGLA DE ORO VITAL**: Todo paciente alcohólico debe recibir TIAMINA EV/IM antes de cualquier solución glucosada para evitar precipitar un Wernicke irreversible.
- El Síndrome de Korsakoff es la secuela crónica e irreversible del Wernicke no tratado, manifestada por amnesia anterógrada severa y confabulación.
- La alucinosis alcohólica ocurre a las **12-24 h** con alucinaciones pero SENSORIO LÚCIDO; el Delirium Tremens ocurre a las **48-72 h** con CONFUSIÓN y disautonomía.
- El Delirium Tremens es una emergencia médica vital (mortalidad hasta **15%**) caracterizada por confusión, agitación, fiebre y zoopsias.
- El Diazepam es la benzodiacepina de elección en abstinencia alcohólica en pacientes con función hepática conservada.
- El Lorazepam es la benzodiacepina obligatoria de elección en pacientes con CIRROSIS HEPÁTICA o insuficiencia hepatocelular porque no genera metabolitos activos.

ALGORITMO · ALCOHOL: DE LA ABSTINENCIA A LA CONDUCTA



PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **67–72** (págs. 18–19) · solucionario págs. 32–33.

Clase 17.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

17.15 Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

PRIORIDAD MEDIA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 17.15 · FASES TEMPORALES DE LA ABSTINENCIA ALCOHÓLICA: CRONOLOGÍA, CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

ETAPA / SÍNDROME	TIEMPO POST-ÚLTIMA INGESTA	MANIFESTACIONES CLÍNICAS CARDINALES	NIVEL DE CONCIENCIA
Abstinencia Leve / Temblor	6 a 12 horas	Temblor fino distal, sudoración, taquicardia, náuseas, ansiedad	Vigil y orientado
Alucinosis Alcohólica	12 a 24 horas	Alucinaciones visuales o auditivas floridas sin amnesia posterior	SENSORIO LÚCIDO Y ORIENTADO (Diferencia con DT)
Convulsiones de Abstinencia	12 a 48 horas	Crisis tónico-clónicas generalizadas, únicas o en salvas breves	Estupor postictal transitorio breve
Delirium Tremens	48 a 96 horas (hasta 7 días)	Confusión global, desorientación, disautonomía severa, zoopsias, fiebre	COMPROMISO SEVERO DE CONCIENCIA Y CONFUSIÓN
Encefalopatía de Wernicke	Cualquier momento (déficit B1)	Tríada: Oftalmoplejía (VI par) + Ataxia de la marcha + Delirium	Confusional agudo / Estupor progresivo

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Alcohólico confuso con hipoglicemia	Tiamina, luego glucosa	Glucosa sola
Alucinaciones y está orientado	Alucinosis alcohólica	Delirium tremens
48 a 96 h, confuso, fiebre, zoopsias	Delirium tremens: benzodiacepina	Haloperidol solo
Abstinencia en cirrótico	Lorazepam	Diazepam
Convulsión de abstinencia	Benzodiacepina aguda	Fenitoína de mantención

REGLA DE ORO **Alucinosis: lúcido; delirium tremens: confuso** — Doce a veinticuatro horas; cuarenta y ocho a noventa y seis

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El trastorno por uso de alcohol es la principal adicción en Chile y la causa de mayor carga de enfermedad por discapacidad y muerte prematura en la población adulta. La dependencia etílica genera una adaptación neuroquímica profunda caracterizada por la desensibilización de los receptores gabaérgicos inhibidores y la hipersensibilización de los receptores glutamatérgicos NMDA excitadores. Cuando el consumo se interrumpe de forma brusca, se produce una tormenta hiperglutamatérgica y noradrenérgica que se manifiesta clínicamente como el Síndrome de Abstinencia Alcohólica, cuyas complicaciones mortales son las convulsiones de abstinencia, el Delirium Tremens (mortalidad hasta el 5%) y la Encefalopatía de Wernicke irreversible. En el EUNACOM se evalúan con rigor absoluto dos axiomas: la administración de Tiamina EV SIEMPRE antes de sueros glucosados, y el uso de benzodiacepinas orales/EV tituladas por la escala CIWA-Ar.

TABLA 17.15.B · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO INTEGRAL EN TRASTORNO POR USO DE ALCOHOL

FASE TERAPÉUTICA	FÁRMACO DE ELECCIÓN	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	REGLAS DE ORO Y ADVERTENCIAS CRÍTICAS
Prevención de Wernicke	Tiamina (Vitamina B1)	100 a 300 mg EV o IM al día por 3 a 5 días	ADMINISTRAR SIEMPRE ANTES DE CUALQUIER SUERO GLUCOSADO
Abstinencia Hepática Normal	Diazepam VO o EV	10 a 20 mg VO c/1-2 h según escala CIWA-Ar	Vida media larga con metabolitos activos · Autotitulación suave
Abstinencia en Cirrótico	Lorazepam VO o SL	2 a 4 mg VO/SL cada 2 horas según CIWA-Ar	No genera metabolitos activos · No se acumula en falla hepática
Deshabituación (Anticraving)	Naltrexona oral	50 mg una vez al día por vía oral	Reduce el placer del alcohol · Prohibido si consume opioides o hepatitis
Deshabituación (Terapia Aversiva)	Disulfiram oral	250 mg al día por vía oral bajo supervisión	Inhibe aldehído deshidrogenasa · Reacción vómitos/shock con alcohol

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **67–72** (págs. 18–19) · solucionario págs. 32–33.

Clase 17.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

17.16 Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
13 preguntas reales 2013–2025

5.01.2.003 Intoxicación por sustancias psicoactivas — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Dependencia de otras drogas · Consumo perjudicial de alcohol y drogas · Consumo perjudicial de drogas en niños y adolescentes · Prevención: Alcohol, tabaco, drogas. Modelo de prevención primaria. · Exámenes de orina para el control de drogas de abuso · Complicaciones neurológicas de abuso de sustancias

LO QUE TE PREGUNTAN

- El toxíndrome simpaticomimético (cocaína, pasta base) se caracteriza por taquicardia, hipertensión severa, hipertermia, diaforesis y midriasis bilateral.
- En el dolor torácico inducido por cocaína, los betabloqueadores puros (Propranolol, Atenolol) están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS por estimulación alfa sin oposición.
- El tratamiento de primera línea de la isquemia y dolor torácico por cocaína son las BENZODIACEPINAS ENDOVENOSAS asociadas a nitratos.
- El Flumazenil está contraindicado en la sobredosis de benzodiacepinas en pacientes con consumo crónico por el riesgo letal de desencadenar status epiléptico.
- **La tríada de sobredosis de opioides es**: miosis puntiforme, depresión respiratoria y coma (se revierte con Naloxona EV).

ALGORITMO · INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS: DEL TOXÍNDROME A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

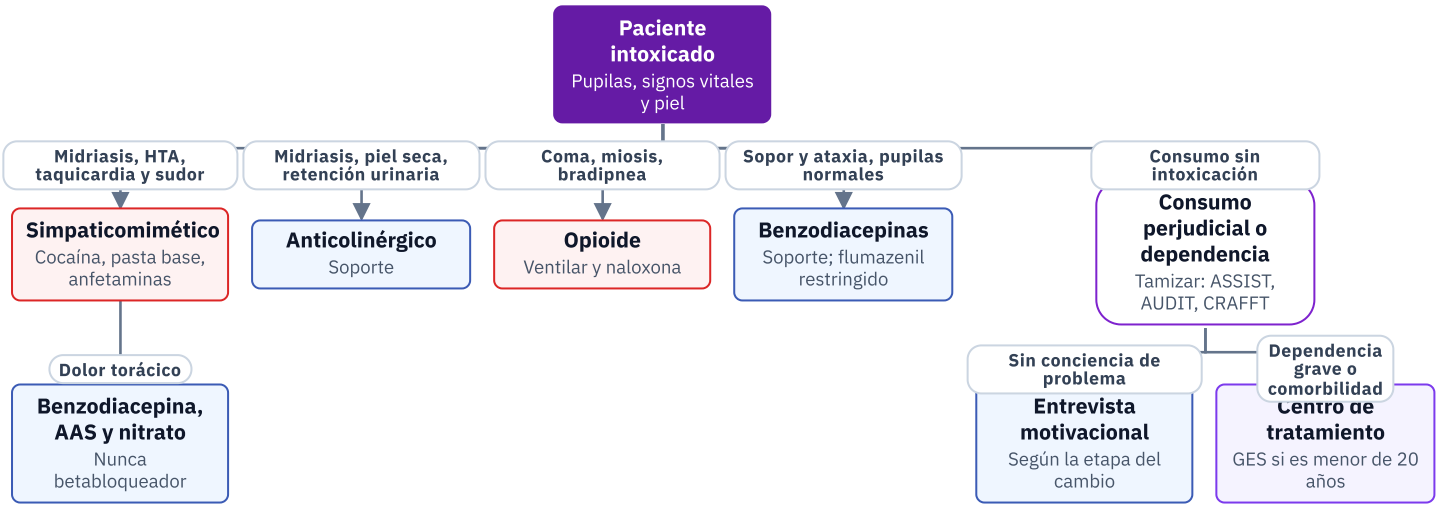


TABLA 17.16 · TOXÍNDROMES MAYORES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS: RECONOCIMIENTO CLÍNICO RÁPIDO

TOXÍNDROME	DROGAS TÍPICAS	SIGNOS VITALES Y PUPILAS	MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y ANTÍDOTO
Simpaticomimético	Cocaína, pasta base, anfetaminas, éxtasis	Taquicardia, HTA severa, hipertermia, MIDRIASIS	Diaforesis, agitación, vasoespasmo · Antídoto: BENZODIACEPINAS EV
Sedante-Hipnótico	Benzodiacepinas, barbitúricos, zolpidem	Hipotensión leve, bradipnea, pupilas normales	Sopor, ataxia, disartria · Soporte ventilatorio (Flumazenil restringido)
Opioide	Morfina, heroína, fentanilo, metadona	BRADIPNEA SEVERA, hipotensión, MIOSIS PUNTIFORME	Coma, depresión respiratoria mortal · Antídoto: NALOXONA EV
Anticolinérgico	Atropina, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos	Taquicardia, hipertermia, MIDRIASIS ARREACTIVA	Piel seca y roja ("rojo como betarraga, seco como hueso, loco como cabra")

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Dolor torácico tras cocaína	Benzodiacepina, aspirina, nitrato	Atenolol o propranolol
Midriasis, HTA, fiebre, sudor	Síndrome adrenérgico: anfetaminas o cocaína	Anticolinérgico
Sobredosis de benzodiacepina en usuario habitual	Soporte ventilatorio	Flumazenil

REGLA DE ORO **Pupila y signos vitales** — Midriasis simpática; miosis, opioide

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **1, 20, 74–77** (págs. 8, 11, 19–20) · solucionario págs. 22, 24, 34.

Clase 17.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

17.17 Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
7 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.016 Trastornos de la personalidad — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Personalidad: Concepto y medición. Principales teorías en psicología de la personalidad

LO QUE TE PREGUNTAN

- Los Trastornos de la Personalidad son patrones perdurables, rígidos y egosintónicos con debut en la adolescencia o adultez joven.
- **Clúster A**: Raros y excéntricos (Paranoide, Esquizoide, Esquizotípico).
- **Clúster B**: Dramáticos e impulsivos (Límite, Antisocial, Histriónico, Narcisista).
- **Clúster C**: Ansiosos y temerosos (Evitativo, Dependiente, Obsesivo-Compulsivo).

ALGORITMO · TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD: DEL CUADRO AL CLÚSTER

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

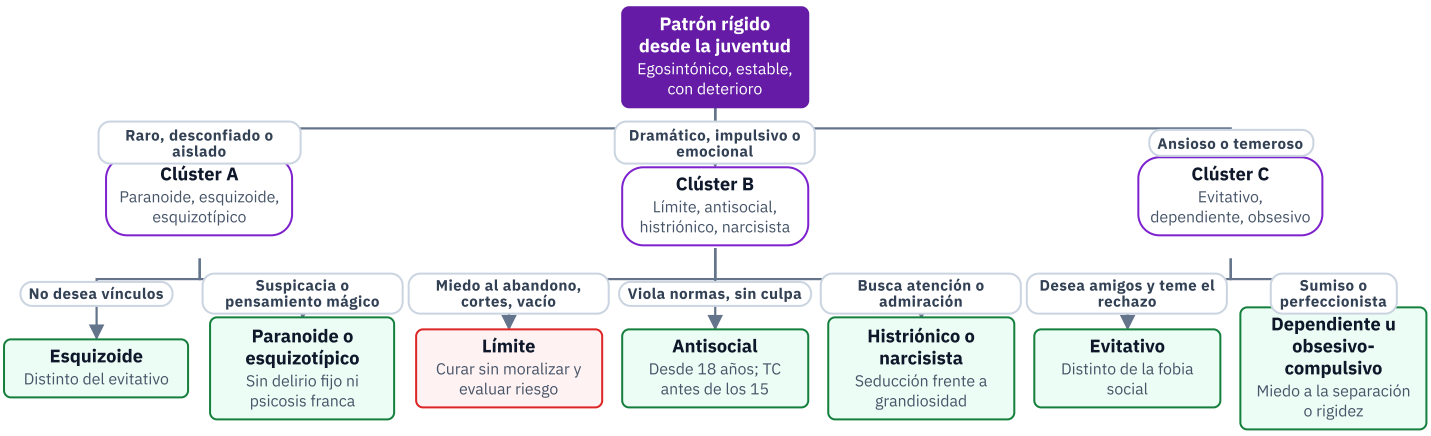


TABLA 17.17 · MATRIZ COMPARATIVA DE LOS 10 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD SEGÚN DSM-5

CLÚSTER	TRASTORNO DE PERSONALIDAD	RASGO CARDINAL DISTINTIVO	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLAVE
Clúster A (Raros)	Paranoide	Suspicacia constante, desconfianza, rencor	Trastorno delirante (en paranoide no hay delirio fijo)
Clúster A (Raros)	Esquizoide	Aislamiento voluntario, frialdad, desinterés social	Evitativo (en esquizoide NO hay deseo de socializar)
Clúster A (Raros)	Esquizotípico	Pensamiento mágico, excentricidad, rarezas	Esquizofrenia (en esquizotípico no hay psicosis franca)

REGLA DE ORO **A raros, B dramáticos, C ansiosos** — Patrón egosintónico desde joven

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **78–85** (págs. 20–21) · solucionario págs. 34–35.

Clase 17.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.028 Trastorno por déficit atencional — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

También: Trastornos de la conducta alimentaria · Trastorno del espectro autista · Trastorno específico del aprendizaje escolar · Retardo mental · Enuresis · Trastorno conducta oposicionista desafiante · Trastorno conducta disocial · Trastornos ansiosos en niños · Tests WAIS y WISC · Síndrome déficit atencional · Trastornos aprendizaje · Trastornos de alimentación · Trastornos neuropsiquiátricos

LO QUE TE PREGUNTAN

- El TDAH exige que varios síntomas de inatención o hiperactividad estén presentes antes de los **12 años** y se manifiesten en al menos 2 entornos distintos (colegio y hogar).
- El Metilfenidato es el tratamiento farmacológico de primera elección en el TDAH en edad escolar.
- En la Anorexia Nervosa el peso corporal es significativamente bajo (IMC < 18.5) con miedo intenso a engordar y distorsión de la silueta corporal.
- **Criterios de hospitalización inmediata en anorexia**: IMC < **13-14 kg**/m², bradicardia < **40 lpm**, hipotensión < 80/**50 mmHg**, QTc > 460 ms e hipokalemia.
- En la Bulimia Nervosa existen atracones seguidos de purgas compensatorias, pero el peso corporal es habitualmente normal o en sobrepeso.

ALGORITMO · ADOLESCENTE CON ALTERACIÓN DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 17.18 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ANOREXIA NERVOSA VS BULIMIA NERVOSA VS TRASTORNO POR ATRACÓN

CARACTERÍSTICA CLÍNICA	ANOREXIA NERVOSA	BULIMIA NERVOSA	TRASTORNO POR ATRACÓN (BINGE EATING)
Peso Corporal / IMC	SIGNIFICATIVAMENTE BAJO (IMC < 18.5; grave < 14)	HABITUALMENTE NORMAL O SOBREPESO	Sobrepeso u Obesidad marcada
Atracones compulsivos	Solo en subtipo purgativo (cantidades pequeñas)	SIEMPRE PRESENTES (grandes cantidades voraces)	SIEMPRE PRESENTES (con gran culpa posterior)
Conductas compensatorias	Restricción extrema, ejercicio extenuante, purgas	SIEMPRE PRESENTES (vómitos, laxantes, ayuno)	ESTRICTAMENTE AUSENTES (no hay purgas)
Distorsión de imagen	Severa (se ve gorda estando caquéctica)	Preocupación excesiva por el peso y la silueta	Malestar subjetivo pero sin distorsión dismórfica
Fármaco de elección	Ningún psicofármaco revierte la emaciación	Fluoxetina en dosis altas (60 mg/día) + TCC	Lisdexanfetamina o Topiramato + TCC

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
IMC 13,7, FC 36, QTc largo	Hospitalizar de inmediato	Manejo ambulatorio
Ingresa una anoréxica grave	Realimentar lento; fósforo, magnesio y tiamina	Dar carbohidratos en cantidad
Peso normal, vómitos, parótidas	Bulimia: fluoxetina y TCC	Anorexia

REGLA DE ORO **TDAH: antes de 12 años y en 2 entornos** — Metilfenidato de primera línea

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **55, 86–90** (págs. 16, 21) · solucionario págs. 30, 36.

Clase 17.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

17.20 Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.017 **Disfunción sexual** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Sexualidad humana y sus alteraciones · Respuesta sexual humana · Disforia de género · Sexualidad, género y diversidad

LO QUE TE PREGUNTAN

- Las fases de Masters y Johnson son excitación, meseta, orgasmo y resolución; el período refractario masculino ocurre en la resolución.
- **Disfunción sexual en el DSM-5**: **6 meses** o más, en **75-100%** de las ocasiones y con malestar significativo.
- Erecciones nocturnas o matinales conservadas orientan a causa psicógena; inicio gradual y generalizado, a causa orgánica o de fármacos.
- ISRS retrasan el orgasmo, los antipsicóticos reducen el deseo por hiperprolactinemia y los iPDE5 están contraindicados con nitratos.
- **Trastorno parafílico**: patrón de **6 meses** o más con malestar, deterioro o falta de consentimiento; exhibicionismo no es lo mismo que voyeurismo ni que frotteurismo.

ALGORITMO · QUEJA SEXUAL: DE LA DEFINICIÓN A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 17.20 · DISFUNCIONES SEXUALES DEL DSM-5: ENTIDAD Y MANEJO INICIAL

ENTIDAD	DEFINICIÓN CLAVE	MANEJO INICIAL
Trastorno eréctil	Dificultad para obtener o mantener la erección	Estudio de factores de riesgo vascular · iPDE5 (contraindicados con nitratos)
Eyaculación precoz	Eyaculación cerca de 1 minuto de la penetración, antes de lo deseado	Parada-inicio o compresión · ISRS o dapoxetina
Eyaculación retardada	Retardo o ausencia de eyaculación	Revisar fármacos (ISRS) · terapia sexual
Deseo hipoactivo (masculino) / interés y excitación (femenino)	Falta de deseo o de excitación	Buscar depresión, fármacos, hipogonadismo y problemas de pareja
Trastorno orgásmico femenino	Retardo o ausencia de orgasmo o intensidad muy reducida	Educación · focalización sensorial · terapia sexual
Dolor genitopélvico / penetración	Dolor, miedo o contracción de la musculatura pélvica en la penetración	Descartar causa orgánica · dilatadores y terapia · fisioterapia del piso pélvico

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Disfunción eréctil, HTA con enalapril	iPDE5 primera línea	Testosterona o consejería sola
Eyaculación en menos de 1 minuto	ISRS o dapoxetina y stop-start	Alprazolam o sildenafil
Idea intrusiva de ser pedófilo, la rechaza	TOC	Parafilia

REGLA DE ORO **Excitación, meseta, orgasmo, resolución** — Refractario masculino en la resolución

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **19, 37** (págs. 11, 13) · solucionario págs. 24, 27.

Clase 17.20 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 20 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS	
17.1 Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	pág. 3
Fluoxetina **20 a 60 mg** al día — Vida media larga	DOSIS
Peso y apetito — Cambio mayor al **5%** en un mes	TIEMPO
Sertralina **50 a 200 mg** al día — Cardiopatía isquémica y lactancia	DOSIS
Prevalencia adulta cerca del **17%** — Mujer a hombre, 2 a 1	CORTE
17.2 Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES	pág. 4
Muestra a las **12 horas** — Después de la última dosis	DOSIS
Quetiapina **300 mg** al día — Lurasidona o cariprazina también	DOSIS
Profilaxis: **0,6 a 1,0 mEq/L** — Manía aguda: 0,8 a 1,2	CORTE
17.3 Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización	pág. 5
Mujeres: más intentos — **3 a 4 veces** más	CORTE
Hombres: más suicidios consumados — **4 a 5 veces** más	CORTE
17.4 Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal	pág. 6
Semana 2 a 6 — Hasta 1 año; afecta a **10 a 15%**	TIEMPO
1 a 2 por 1.000 partos — Primeras **1 a 2 semanas**	TIEMPO
Sertralina: primera elección — **50 a 100 mg**; casi no pasa a la leche	DOSIS
Día 3 a 5 del posparto — Afecta a **50 a 80%** de las madres	TIEMPO
17.5 Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo	pág. 7
2 años en adultos — 1 año en niños y adolescentes	CORTE
Somatización, hipocondría, dolor persistente — Somatización: varios sistemas, antes de los **30 años**	CORTE
BLOQUE 02 · TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA	
17.6 Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS	pág. 8
Antes de iniciar litio — Y luego cada **6 a 12 meses**	TIEMPO
El litio da hipotiroidismo y bocio — Hasta **20 %**; se agrega levotiroxina, sin suspender	CORTE
17.7 Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social	pág. 9
Venlafaxina como alternativa — **75 a 150 mg** al día	DOSIS
Pasadas **4 a 8 semanas** — Tolerancia, dependencia, memoria	TIEMPO
La más frecuente: **7 a 9 %** de la población — Inicio en la infancia	CORTE
17.8 Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS	pág. 10
Más de **1 hora** al día — O malestar y deterioro significativos	TIEMPO
17.9 Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo	pág. 11
Prazosina al acostarse — **1 a 5 mg**, dosis baja al inicio	DOSIS
De **3 días** a **1 mes** — Si pasa de un mes: TEPT	TIEMPO
BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS	
17.10 Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES	pág. 12
Olanzapina **10 a 20 mg** — Sedante; alerta metabólica	DOSIS
Risperidona **2 a 6 mg** — Sobre **6 mg**: más SEP y prolactina	DOSIS
Aripiprazol **10 a 30 mg** — Agonista parcial D2; no engorda	DOSIS
Quetiapina **300 a 800 mg** — Sedante; casi sin efectos motores	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
17.11 Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma	pág. 13
El más eficaz de todos — **100 a 400 mg** al día	DOSIS
Convulsiones: sobre **600 mg** — Bajar dosis y agregar valproato	DOSIS
Agranulocitosis en cerca de **0,8%** — Potencialmente mortal	CORTE
Desde el año: mensual — Mientras la tome y **4 semanas** después	TIEMPO
17.12 Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve	pág. 14
Dura de **1 a 6 meses** — Si pasa de **6 meses**: esquizofrenia	TIEMPO
17.13 Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo	pág. 15
Acidosis metabólica láctica — pH < 7,25 en los graves	DOSIS
CPK > 1.000, a menudo > 10.000 — Puede llegar a **50.000 UI**/L	DOSIS
17.14 Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada	pág. 16
Quetiapina **25 mg** VO — Alternativa atípica	DOSIS
Haloperidol **0,5 a 1 mg** VO o IM — Solo si hay riesgo	DOSIS
17.19 Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense	pág. 17
Adulto: **7 a 9 horas** — Ciclos de unos **90 minutos** NREM y REM	TIEMPO
Cafeína, tabaco y alcohol de noche — Cafeína **6 a 8 horas** antes	TIEMPO
BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL	
17.15 Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke	pág. 18
Lorazepam: sin metabolitos activos — **2 a 4 mg** VO o SL cada **2 h**	DOSIS
Mortalidad de **5 a 15 %** sin tratamiento — Hospitalizar	CORTE
Profilaxis: **100 a 250 mg** al día IM o EV — Todo alcohólico hospitalizado	DOSIS
17.16 Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)	pág. 20
Benzodiacepinas EV — Diazepam **5-10 mg** o lorazepam **2-4 mg**	DOSIS
Aspirina y nitroglicerina — AAS **250 mg**; nitrato sublingual	DOSIS
Coma, miosis y depresión respiratoria — Naloxona **0,4-2 mg** IV, IM o intranasal	DOSIS
17.17 Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C	pág. 21
Antisocial: viola los derechos ajenos — Sin remordimiento, desde los **15 años**	CORTE
Esquizoide no desea; evitativo sí desea — Antisocial: **18 años** y TC antes de los 15	CORTE
17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria	pág. 22
K < 3, hipofosfatemia, hipoglicemia — Trastornos metabólicos	META
Bradicardia, hipotensión, hipotermia — FC < **50 lpm**	CORTE
FC < 40, PAS < 80, QTc > 460 — Arritmias ventriculares	CORTE
CI < 70 y déficit adaptativo — Inicio en el desarrollo	CORTE
17.20 Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad	pág. 23
6 meses o más — Duración mínima	TIEMPO
En el **75 a 100 %** de las ocasiones — Casi siempre	CORTE

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
17.1 Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES			pág. 3
Mantenimiento · Derivar si recae en tratamiento	**O falla a dos antidepresivos, psicosis, riesgo**		
17.6 Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS			pág. 8
Implicancias · Corregir la tiroides suele resolver el síntoma	**Betabloqueador para temblor y ansiedad**		
Implicancias · El litio da hipotiroidismo y bocio	**Hasta 20 %; se agrega levotiroxina, sin suspender**		
17.7 Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social			pág. 9
Fobia específica · Primera línea	**Solo puntual: benzodiacepina o betabloqueador**		
17.10 Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES			pág. 12
Antipsicóticos de segunda generación · Otros dos	**Aripiprazol 10 a 30 mg**	Agonista parcial D2; no engorda	
17.11 Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma			pág. 13
¿Cuándo es refractaria? · Qué se hace	**Clozapina: elección indiscutida**	Nivel secundario y farmacovigilancia	
17.12 Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve			pág. 14
Fármacos y seguridad · Antipsicótico atípico	**Aripiprazol o risperidona**		
17.14 Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada			pág. 16
Contención farmacológica · Si rechaza: intramuscular	**Alternativa: olanzapina o aripiprazol IM**	Olanzapina **10 mg**; aripiprazol **9,75 mg**	
17.15 Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke			pág. 18
Fármacos para mantener la abstinencia · Naltrexona 50 mg al día	**Reduce el craving; no con opioides ni hepatitis**		
17.16 Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)			pág. 20
Benzodiacepina sí, betabloqueador no · Qué se hace	**Aspirina y nitroglicerina**	AAS **250 mg**; nitrato sublingual	
17.20 Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad			pág. 23
Fármacos que lo causan	**Antipsicóticos, betabloqueadores, tiazidas**	Y espironolactona	

GES de Psiquiatría y Salud Mental

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 21): Depresión en personas de 15 años y más · Sospecha con confirmación diagnóstica en ≤ 24 horas en Atención Primaria de Salud (APS), inicio inmediato de psicoterapia y farmacoterapia (ISRS de 1.ª línea), y control clínico presencial a las 2 semanas.**

Tema **17.1** · Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES
`5.01.1.007` · `5.01.1.008` · `5.01.1.034`
pág. **3**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 52): Trastorno Bipolar en personas de 15 años y más · Confirmación diagnóstica por médico especialista en psiquiatría en ≤ 60 días desde la sospecha, inicio inmediato de tratamiento farmacológico estabilizador del ánimo y hospitalización de urgencia protegida en episodio maníaco agudo.**

Tema **17.2** · Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES
`5.01.1.009` · `5.01.4.003`
pág. **4**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 21): Depresión en personas de 15 años y más · Tamizaje universal obligatorio con Escala de Edimburgo (EPDS) en controles de niño sano a los 2 y 6 meses en APS · Manejo con psicoterapia y fármacos compatibles con la lactancia.**

Tema **17.4** · Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal
`5.01.1.007`
pág. **6**

GES **GES N° 21 en caso de sobreimposición de episodio depresivo mayor ("depresión doble") · Manejo en APS con psicoterapia de apoyo y resolución de estresores psicosociales.**

Tema **17.5** · Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo
`5.01.1.004` · `5.01.1.020`
pág. **7**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 34): Primer Episodio de Esquizofrenia en personas de 15 años y más · Sospecha con confirmación diagnóstica en ≤ 20 días por médico psiquiatra, e inicio de tratamiento farmacológico y psicosocial integral en ≤ 24 horas desde la confirmación.**

Tema **17.10** · Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES
`5.01.1.010` · `5.01.5.002`
pág. **12**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 34): Canasta de Esquizofrenia Refractaria · Programa Nacional de Farmacovigilancia de Clozapina con monitoreo hematológico obligatorio.**

Tema **17.11** · Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma
`5.01.1.010` · `1.08.4.008`
pág. **13**

GES **Norma Técnica de Salud Mental MINSAL · Sin cobertura GES directa para trastorno delirante crónico no esquizofrénico · Derivación a COSAM.**

Tema **17.12** · Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve
`5.01.1.010`
pág. **14**

GES **Garantía GES Consumo Perjudicial o Dependencia de Alcohol y Drogas en personas menores de 20 años · Programa Nacional de Detección e Intervención Breve del Alcoholismo MINSAL en APS.**

Tema **17.15** · Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke
`5.01.1.012` · `1.10.2.004` · `1.10.3.001`
pág. **18**

GES **Garantía GES Consumo de Drogas en menores de 20 años · Programa Nacional SENDA / MINSAL.**

Tema **17.16** · Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)
`5.01.2.003` · `5.01.1.013` · `5.01.1.011`
pág. **20**

Sin garantía GES específica (11 temas): 17.3 · 17.6 · 17.7 · 17.8 · 17.9 · 17.13 · 17.14 · 17.19 · 17.17 · 17.18 · 17.20. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

4 temas · ★★★

- ★★★ **17.11** Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma 13
- ★★★ **17.10** Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES 12
- ★★★ **17.12** Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve 14
- ★★★ **17.1** Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES 3

Practica: Libro Gordo Psiquiatría General, preguntas 3–17, 38–46, 56–57.

DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **17.6** Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS 8
- ★★★ **17.4** Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal 6
- ★★★ **17.5** Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo 7
- ★★★ **17.18** Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria 22

Practica: Libro Gordo Psiquiatría General, preguntas 21–29, 55, 86–90.

DÍA 3

3 temas · ★★

- ★★☆ **17.9** Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo 11
- ★★☆ **17.16** Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas) 20
- ★★☆ **17.2** Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES 4

Practica: Libro Gordo Psiquiatría General, preguntas 1, 18, 20, 47–54, 74–77.

DÍA 4

3 temas · ★★

- ★★☆ **17.7** Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social 9
- ★★☆ **17.15** Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke 18
- ★★☆ **17.8** Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS 10

Practica: Libro Gordo Psiquiatría General, preguntas 30–36, 67–72.

DÍA 5

3 temas · ★

- ★☆☆ **17.14** Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada 16
- ★☆☆ **17.19** Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense 17
- ★☆☆ **17.17** Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C 21

Practica: Libro Gordo Psiquiatría General, preguntas 62–66, 78–85.

DÍA 6

3 temas · ★

- ★☆☆ **17.13** Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo 15
- ★☆☆ **17.3** Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización 5
- ★☆☆ **17.20** Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad 23

Practica: Libro Gordo Psiquiatría General, preguntas 2, 19, 37, 58–61.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 24
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 17.1 · 17.4 · 17.5 · 17.6 · 17.10 · 17.11 · 17.12 · 17.18
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Psiquiatría General en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 8 temas

35 17.11. Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma GES 13
34 17.10. Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES GES 12
34 17.12. Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve GES 14
25 17.1. Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES GES 3
20 17.6. Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS 8
19 17.4. Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal GES 6
19 17.5. Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo GES 7
19 17.18. Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria 22

★★ Prioridad media · 6 temas

16 17.9. Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo 11
13 17.16. Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas) GES 20
12 17.2. Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES GES 4
12 17.7. Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social 9
12 17.15. Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke GES 18
11 17.8. Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS 10

★ Prioridad baja · 6 temas

8 17.14. Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada 16
8 17.19. Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense 17
7 17.17. Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C 21
5 17.13. Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo 15
2 17.3. Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización 5
2 17.20. Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad 23